医療AIの倫理

医療AIの倫理 — 知っておきたい6つのチェックポイント

全スタッフ向けスライド（10分）

参考文献

2026-03-29 ・ AI(Claude)作成・主な出典は原典で確認

AIが「この患者さん、危ないです」と言ったら？

身近なシナリオから考えよう

想像してみてください:

ある日、病棟の電子カルテに新しい機能が追加されました。

AIが入院患者の状態を自動分析し、「急変リスク: 高」とアラートを出します。

- 看護師さん: バイタル異常なし。でもAIは「危険」と言っている…
- 薬剤師さん: AIが薬の相互作用を指摘。でも長年使ってきた組み合わせ…
- リハビリさん: AIが「今日は運動負荷を下げるべき」と提案…

今日のゴール: 医療AIを安全に使うための「6つのチェックポイント」を知り、自分の仕事に1つ当てはめられるようになる

そもそもAIってどこまで来ているの？

医療の世界でのAI活用の現在地

すでに使われている医療AI:

場面	AIの役割	例
画像診断	レントゲン・CTの異常検出	胸部X線の肺結節スクリーニング
予測	急変・再入院リスク予測	敗血症早期警告システム
投薬	薬物相互作用チェック	処方オーダーの自動アラート
業務支援	書類作成・要約	退院サマリーの下書き

大事なこと: AIは「道具」であり、最終判断は必ず人間が行います

6つのチェックポイント

世界の研究22件から見えてきた倫理的課題

最新のシステマティックレビュー（Wubineh et al., 2026）が整理した6カテゴリ:

#	チェックポイント	ひとことで言うと
1	透明性と信頼	AIがなぜそう判断したか、分かるか？
2	偏り（バイアス）と公平性	全ての患者さんに同じように正確か？
3	プライバシー	患者さんのデータは守られているか？
4	責任の所在	間違いがあったら誰が責任を取るか？
5	道徳的な問題	AIに任せていいことの線引きは？
6	法律とルール	法整備は追いついているか？

6つのチェックポイントの全体像



出典: Wubineh et al., BMC Medical Ethics 2026（システマティックレビュー）

具体例で理解しよう

「偏り（バイアス）」って何？

実際にあった事例:

皮膚科のAIが「この皮膚病変は良性です」と判断。

しかしこのAIは、**明るい肌トーンの画像データ**で主に訓練されていた。

結果: 暗い肌トーンの患者さんでは、皮膚がんを見逃すリスクが上昇。

具体例で理解しよう（続き）

なぜこうなるか:

- AIは訓練に使ったデータの特徴を学ぶ
- データに偏りがあると、特定の患者さんで精度が下がる
- 高齢者、少数民族、農村部の住民はデータが少ないことが多い

あなたの職場では: 導入されたAIが「どんなデータで訓練されたか」を確認する習慣が大切

各職種でできること

グループ対話 —「うちの職場なら？」

3分間、隣の人と話してみましょう:

「もし自分の職場にAIが導入されたら、6つのチェックポイントのうち、どれが一番気になる？」

職種	考えるヒント
看護師	AIアラートと患者さんの訴えが食い違ったら？
薬剤師	AI処方チェックを過信して見落とすリスクは？
リハビリ	AI推奨と患者さんの意欲のバランスは？
事務	患者データがAIに使われることの説明は？
医師	AIの推奨を採用/却下した根拠をどう記録する？

世界と日本の動き

ルールはどう変わっていくか

EU(ヨーロッパ):

- EU AI法は2024年に発効し、高リスクAIの義務の適用は延期された(2026年7月の改正で、医療機器に組み込まれるAIは2028年8月、それ以外の分野別の高リスクAIは2027年12月から)
- 医療機器に組み込まれるAIは「高リスクAI」に分類 → 技術文書・人間の監視などが義務化
- スタッフのAIリテラシーを高める措置を取る義務は2025年2月から(2026年7月の改正で、一定水準の保証までは求めない形に)

世界と日本の動き（続き）

日本:

- AI推進法（人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律）が2025年5月に成立し、同年9月に全面施行
- 厚労省「医療デジタルデータのAI研究開発等への利活用に係るガイドライン」が公表されている
- 令和8年度診療報酬改定の基本方針（2025年12月）に、AI・ICT（Information and Communications Technology / 情報通信技術）等の利活用による業務効率化と医療DXの推進が盛り込まれた

ポイント: 「AIを使えること」だけでなく「AIを安全に使えること」が求められる時代へ

まとめ

今日のまとめと明日からのアクション

1つだけ持ち帰ろう

6つのチェックポイント（おさらい）:

透明性 / 偏り / プライバシー / 責任 / 道徳 / 法律

まとめ

今日のまとめと明日からのアクション（続き）

職種別アクション（1つだけでOK）:

職種	明日からできること
看護師	AIアラートが出たとき「なぜ？」と1回聞く習慣をつける
薬剤師	AI処方チェックの結果を「ダブルチェックの1つ」として位置づける
リハビリ	AI提案を参考にしつつ、患者さんとの対話を最優先にする
事務	患者さんからAIについて聞かれたら、担当者につなぐ窓口を確認する
医師	AIの推奨と自分の判断が異なるとき、理由をカルテに一言メモする

まとめ

今日のまとめと明日からのアクション（続き）

大切なのは「AIを怖がる」ことではなく、「AIと上手につきあう」こと。
そのための第一歩が、今日の6つのチェックポイントです。

参考文献

Wubineh BZ, Deriba FG, Gemeda FW. Ethical concerns and strategies for implementing artificial intelligence in healthcare: a review of empirical studies. BMC Medical Ethics. 2026;27(1):53. https://doi.org/10.1186/s12910-026-01404-8

Harvard Gazette. AI is speeding into healthcare — who should regulate it? 2026. https://news.harvard.edu/gazette/story/2026/01/ai-is-speeding-into-healthcare-who-should-regulate-it/

WHO. AIの倫理とガバナンス：大規模マルチモーダルモデルに関するガイダンス. 2024. https://www.who.int/publications/i/item/9789240084759